Клинические рекомендации

Сотрясение головного мозга

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S06.0** — Сотрясение головного мозга
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2026, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/734_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Критерии диагноза 3

3.2 Жалобы и анамнез 3

3.3 Физикальное обследование 3

3.4 Инструментальные исследования 4

3.5 Консультации специалистов 4

4. Лечение 4

4.1 Режим и активность 4

4.2 Головная боль и нарушения сна 4

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Диспансерное наблюдение 5

5.2 Показания к госпитализации 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 5

1. Основные положения

- Сотрясение головного мозга — наиболее лёгкая клиническая форма диффузного транзиторного повреждения мозга без видимых изменений на КТ; вместе с ушибом мозга лёгкой степени относится к лёгкой черепно-мозговой травме.
- **Оториноларингологу**
  1. признаки перелома основания черепа: кровоподтёки в области сосцевидного отростка, периорбитальные гематомы, истечение жидкости из наружных слуховых проходов, носа, рта;
  2. при жалобах или для объективизации диагноза показан осмотр оториноларинголога;
  3. при бессимптомном течении динамическое отоневрологическое исследование (аудиометрия, электронистагмография, электрогустометрия) выявляет симптомы раздражения вестибулярного анализатора без признаков выпадения.
- КТ головного мозга выполняется при наличии факторов риска: возраст **старше 60 лет**, рвота, судороги, антикоагулянтная терапия, снижение сознания по шкале комы Глазго, подозрение на перелом черепа, длительная посттравматическая амнезия.
- При установленном диагнозе допустимо амбулаторное лечение; строгий постельный режим не рекомендуется. В первые **48 часов** следует воздерживаться от использования экрана: это ускоряет регресс симптомов.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Лёгкая черепно-мозговая травма — остро развившееся нарушение функции мозга вследствие травматического воздействия, при котором может отмечаться кратковременная потеря сознания (**до 30 минут**) и/или амнезия (**до 24 часов**); включает сотрясение головного мозга и ушиб мозга лёгкой степени.

Сотрясение головного мозга — наиболее лёгкая клиническая форма диффузного транзиторного повреждения мозга, в основе которого лежат метаболические, ионные, нейротрансмиттерные нарушения и нейровоспаление; видимые изменения на КТ отсутствуют.

2.2 Этиология и эпидемиология

Сотрясение мозга обусловлено преимущественно инерционной травмой при определённых параметрах углового и трансляционного ускорения, но может возникать и при ударном ускорении. Ушиб мозга отличается от сотрясения макроструктурными повреждениями мозгового вещества.

Лёгкая черепно-мозговая травма составляет 60–95% всех случаев черепно-мозгового травматизма; соотношение сотрясения и ушиба лёгкой степени — примерно 4:1. Смертность при лёгкой травме низкая (0,04–0,29%) и практически исключительно вызвана внутричерепными гематомами.

2.3 Классификация

Клинические формы черепно-мозговой травмы

1. сотрясение мозга;
2. ушиб мозга лёгкой, средней и тяжёлой степени;
3. диффузное аксональное повреждение;
4. сдавление мозга;
5. сдавление головы.

Острый период при сотрясении мозга длится **до 2 недель**, промежуточный период при лёгкой травме — **до 2 месяцев**.

2.4 Клиническая картина

Сотрясение характеризуется нарушением сознания после травмы от нескольких секунд до нескольких минут и амнезией на короткий период (от нескольких минут **до 1 часа**); у 70% отмечается кратковременная утрата сознания в момент травмы.

Субъективные симптомы

1. головная боль (до 90%);
2. несистемное головокружение (около 70–75%);
3. тошнота, рвота, преимущественно однократная (около 35%);
4. общая слабость, быстрая утомляемость;
5. шум в ушах (10%), светобоязнь (10%);
6. вегетативные симптомы, нарушение сна, боли при движении глазных яблок, нарушение конвергенции.

Регресс симптоматики у подавляющего большинства пострадавших происходит в среднем за **4–5 суток**, временная нетрудоспособность обычно не превышает двух недель. При сохранении симптомов **более 7 суток** необходимы дополнительное обследование и выяснение причин.

У 5–50% пострадавших могут отмечаться более длительные физические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие расстройства — персистирующий постконтузионный синдром.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы с потерей или нарушением сознания со слов пострадавшего или очевидцев;
2. физикального обследования: раны и ссадины на голове, признаки перелома костей черепа;
3. тщательного неврологического осмотра при поступлении и в динамике;
4. КТ головного мозга по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. механизм травмы: ускорение-замедление, ударно-противоударный, минно-взрывной;
2. факт нарушения сознания и его длительность;
3. наличие посттравматической амнезии и её длительность.

Важной прогностической характеристикой является длительность посттравматической амнезии: при амнезии **менее 24 часов** хорошее восстановление отмечается у 100% пациентов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре головы выявляют

1. признаки перенесённой травмы: ушибы, ссадины, раны;
2. кровоподтёки в области сосцевидного отростка, периорбитальные гематомы;
3. истечение жидкости из наружных слуховых проходов, носа, рта — признаки перелома основания черепа.

Неврологический осмотр с оценкой по шкале комы Глазго проводится при поступлении и в динамике; показан осмотр нейрохирурга или невролога. Мелкоразмашистый нистагм, анизорефлексия, атаксия, лёгкие оболочечные симптомы исчезают у 90% пациентов **в течение 4–5 суток**.

3.4 Инструментальные исследования

Основные факторы риска — показания к КТ головного мозга

1. возраст **старше 60 лет**, рвота, посттравматические судороги, антикоагулянтная терапия;
2. менее 15 баллов по шкале комы Глазго или снижение **на 2 и более балла**;
3. подозрение на открытый или вдавленный перелом черепа, клинические признаки повреждения основания или свода черепа;
4. посттравматическая амнезия **более 4 часов**, опасный механизм травмы (ДТП).

Дополнительные факторы: возраст 40–60 лет, потеря сознания, персистирующая антероградная амнезия, амнезия 2–4 часа, очаговая неврологическая симптоматика. При невозможности КТ выполняют рентгенографию черепа и эхоэнцефалографию.

3.5 Консультации специалистов

При наличии жалоб или для объективизации диагноза показан осмотр офтальмолога, оториноларинголога, психиатра.

Отоневрологическое исследование при бессимптомном течении

1. аудиометрия;
2. электронистагмография;
3. электрогустометрия.

Оно выявляет симптомы раздражения вестибулярного анализатора при отсутствии признаков выпадения.

Исключительное значение для диагностики приобретает динамика признаков: их обычное исчезновение **через 3–5 суток** подтверждает диагноз сотрясения мозга.

---

4. Лечение

4.1 Режим и активность

Постельный режим с исключением всей внешней стимуляции на протяжении всего срока наблюдения не рекомендуется: он не улучшает восстановление. После начального периода покоя необходимо постепенное возвращение к повседневной активности; деятельность с риском повторной травмы мозга исключают до полного клинического восстановления.

Рекомендуется отказ от деятельности, требующей внимания и концентрации, в частности от использования экрана **в течение первых 48 часов**: регресс симптомов ускоряется с 8 **до 3,5 суток**. Противоэпилептические препараты с профилактической целью не рекомендуются.

4.2 Головная боль и нарушения сна

В первую очередь — немедикаментозное лечение головной боли

1. нормализация сна;
2. регулярное питание и достаточный питьевой режим;
3. исключение стрессовых факторов;
4. умеренная физическая нагрузка.

При головной боли напряжения назначают анальгетики, кроме опиоидов, при неэффективности — комбинированные анальгетики.

При нарушениях сна назначают мелатонин 2 мг в сутки (возможно 3 мг); производные бензодиазепина не рекомендуются.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Показано наблюдение невролога с оценкой общего состояния, неврологического и психического статуса **через 1, 3 и 6 месяцев**. Клинически значимые отдалённые последствия к году после травмы наблюдаются примерно в 10–15% случаев.

5.2 Показания к госпитализации

Амбулаторное лечение под наблюдением невролога проводится при условии выполнения КТ головного мозга или отсутствия показаний к ней.

Показания к госпитализации

1. ушибленные раны головы с кровопотерей;
2. выраженная общемозговая симптоматика.

Госпитализация — в нейрохирургическое отделение, при его отсутствии — в травматологическое или неврологическое. Критерий выписки — клиническое улучшение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Сотрясение головного мозга»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	734_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.